

1. Fluxo tradicional

O macroprocesso tradicional de provisão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) no Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado em etapas sequenciais que vão da avaliação clínica à burocracia administrativa. O processo inicia-se com a avaliação física e funcional do paciente, seguida da elaboração da prescrição técnica. Em seguida, a solicitação passa pela regulação e concessão administrativa, com verificação da elegibilidade e disponibilidade orçamentária. Essa etapa frequentemente apresenta gargalos operacionais que retardam o encaminhamento para a produção. Após a aprovação, a demanda segue para os processos licitatórios e para a fabricação por empresas contratadas. Somente então ocorrem a prova, os ajustes e a entrega do dispositivo. A demora entre a avaliação inicial e a entrega pode comprometer a adequação do equipamento, principalmente em crianças, cujo crescimento durante o período de espera pode tornar o dispositivo incompatível com suas dimensões corporais, prejudicando sua funcionalidade, autonomia e participação social.

Além dos impactos ao paciente, esse fluxo sobrecarrega os cuidadores, que frequentemente assumem longas jornadas de assistência devido à ausência ou inadequação da tecnologia assistiva, favorecendo desgaste físico e emocional. Diante dessas limitações, a literatura aponta para a modernização do fluxo assistencial por meio da Saúde Digital, da integração com o SisAssistiva e de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, visando tornar a concessão de tecnologias assistivas mais ágil e precisa.

Caso clínico (fluxo tradicional de OPM no SUS)

Maria, 7 anos, apresenta paralisia cerebral do tipo diparética espástica e necessita de uma cadeira de rodas adaptada para garantir mobilidade, postura adequada e participação nas atividades escolares. Após avaliação da equipe multiprofissional do SUS, foi realizada a prescrição do dispositivo e encaminhada a solicitação para os trâmites administrativos.

O processo seguiu o fluxo tradicional de concessão de OPM, passando pela análise regulatória, autorização administrativa, processo licitatório e fabricação pela empresa contratada. Entre a avaliação inicial e a entrega transcorreram aproximadamente oito meses. Nesse período, devido ao crescimento da criança, as medidas antropométricas utilizadas na prescrição tornaram-se desatualizadas. Na etapa de prova, verificou-se que a cadeira apresentava inadequações dimensionais, exigindo novos ajustes e prolongando ainda mais o tempo até a entrega definitiva.

Durante esse período, Maria permaneceu com limitações para frequentar a escola e participar de atividades recreativas, enquanto sua mãe precisou intensificar os cuidados diários, realizando transporte manual e adaptações improvisadas, o que resultou em sobrecarga física e emocional. O caso ilustra como os gargalos do fluxo tradicional podem comprometer a efetividade da tecnologia assistiva, especialmente na população pediátrica,

em que o crescimento corporal torna essencial a redução do tempo entre a avaliação e a entrega do dispositivo.